

Malang, 3 Februari 2026

Nomor : 108/DPM/I-PB/DIR/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan

Kepada Yth.

1. Direktur RS Prima Husada Sukorejo
2. PLT Direktur RS Prima Husada Malang

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan dan penyesuaian Pedoman Praktik Klinis *Clinical Pathway* (PPK CP), dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Format pembuatan PPK CP sebagaimana terlampir merupakan format inti/pokok yang digunakan sebagai acuan dasar penyusunan.
2. Format tersebut tidak bersifat kaku dan dapat dilakukan penyesuaian, meliputi penambahan, pengurangan, maupun pengembangan isi, sesuai dengan:
 - a. kebutuhan pelayanan,
 - b. karakteristik kasus,
 - c. dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PPK CP.
3. Setiap penyusunan dan penyesuaian PPK CP wajib dilakukan dengan koordinasi bersama dokter terkait, guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan klinis, alur pelayanan, serta praktik medis yang berlaku.
4. Penyesuaian yang dilakukan tetap harus menjaga prinsip mutu, keselamatan pasien, dan keselarasan dengan kebijakan internal rumah sakit.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Direktur PT Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

Lampiran : I (Satu)
Nomor : 108/DPM/I-PB/DIR/II/2026
Tanggal : 3 Februari 2026

FORMAT PPK RS

LOGO RS NAMA RS	PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) KELOMPOK SMF
DIAGNOSA PENYAKIT	
Definisi	
Anamnesis	
Pemeriksaan Fisik	
Pemeriksaan Penunjang	
Kriteria Pelayanan	
Diagnosis Kerja	
Diagnosis Banding	
Tata Laksana	
Edukasi	
Prognosis	
Penelaah Kritis	
Indikator	
Kepustakaan	

LOGO RS NAMA RS	PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) KELOMPOK SMF
DIAGNOSA PENYAKIT	Typhoid fever (A01.0)
Definisi	Demam Tifoid adalah penyakit sistemik akut yang disebabkan oleh infeksi kuman <i>Salmonella typhi</i> atau <i>Salmonella paratyphi</i>
Anamnesis	1. Demam turun naik terutama sore dan malam hari dengan pola intermiten dan kenaikan suhu <i>step-ladder</i>. Demam tinggi dapat terjadi terus menerus (demam kontinu) hingga minggu kedua. 2. Sakit kepala (pusing-pusing) yang sering dirasakan di area frontal 3. Gangguan gastrointestinal berupa konstipasi dan meteorismus atau diare, mual, muntah, nyeri abdomen dan BAB berdarah 4. Gejala penyerta lain, seperti nyeri otot dan pegal-pegal, batuk, anoreksia, insomnia 5. Pada demam tifoid berat, dapat dijumpai penurunan kesadaran atau kejang.

Pemeriksaan Fisik	- Keadaan umum biasanya tampak sakit sedang atau sakit berat. - Kesadaran: dapat <i>compos mentis</i> atau penurunan kesadaran(mulai dari yang ringan, seperti apatis, somnolen, hingga yang berat misalnya delirium atau koma) - Demam, suhu > 37,5°C. - Dapat ditemukan bradikardia relatif, yaitu penurunan frekuensi nadi sebanyak 8 denyut per menit setiap kenaikan suhu 1°C. - Ikterus - Pemeriksaan mulut: <i>typhoid tongue</i>, tremor lidah, halitosis - Pemeriksaan abdomen: nyeri (terutama regio epigastrik), hepatosplenomegali - Delirium pada kasus yang berat Pemeriksaan fisik pada keadaan lanjut - Penurunan kesadaran ringan sering terjadi berupa apatis dengan kesadaran seperti berkabut. Bila klinis berat, pasien dapat menjadi somnolen dan koma atau dengan gejala-gejala psikosis (<i>organic brain syndrome</i>). - Pada penderita dengan toksik, gejala delirium lebih menonjol. - Nyeri perut dengan tanda-tanda akut abdomen
Pemeriksaan Penunjang	- Darah perifer lengkap beserta hitung jenis leukosis Dapat menunjukkan: leukopenia/ leukositosis/ jumlah leukosit normal, limfositosis relative, monositosis, trombositopenia (biasanya ringan), anemia - Serologi Enzyme <i>Immunoassay test</i> (Typhidot) - Dapat mendeteksi IgM dan IgG <i>Salmonella typhi</i> - Dapat dilakukan pada 4-5 hari pertama demam - Elektrolit untuk pasien dengan kondisi dehidrasi berat
Kriteria Pelayanan	Kriteria rawat jalan: - Tifoid tanpa komplikasi - Tidak ada gangguan hemodinamik Kriteria rawat inap: - Pasien dengan muntah persisten - Gangguan ABC

	3. Diare hebat hingga muncul tanda dehidrasi sedang dan berat. Tanda dehidrasi sebagai berikut : Tabel 9. Pemeriksaan Derajat Dehidrasi <table><tr><th rowspan="2">Gejala</th><th colspan="3">Derajat Dehidrasi</th></tr><tr><th>Minimal (<3% dari BB)</th><th>Ringan sampai sedang (3-9% dari BB)</th><th>Berat (>9% dari BB)</th></tr><tr><td>Status mental</td><td>Baik, sadar penuh</td><td>Normal, lemas, atau gelisah, iritabel</td><td>Apatis, letargi, tidak sadar</td></tr><tr><td>Rasa haus</td><td>Minum normal, mungkin menolak minum</td><td>Sangat haus, sangat ingin minum</td><td>Tidak dapat minum</td></tr><tr><td>Denyut jantung</td><td>Normal</td><td>Normal sampai meningkat</td><td>Takikardi, pada kasus berat brakikardi</td></tr><tr><td>Kualitas denyut nadi</td><td>Normal</td><td>Normal sampai menurun</td><td>Lemah atau tidak teraba</td></tr><tr><td>Pernapasan</td><td>Normal</td><td>Normal cepat</td><td>Dalam</td></tr><tr><td>Mata</td><td>Normal</td><td>Sedikit cekung</td><td>Sangat cekung</td></tr><tr><td>Air mata</td><td>Ada</td><td>Menurun</td><td>Tidak ada</td></tr><tr><td>Mulut dan lidah</td><td>Basah</td><td>Kering</td><td>Pecah-pecah</td></tr><tr><td>Turgor kulit</td><td>Baik</td><td>< 2 detik</td><td>> 2 detik</td></tr><tr><td>Isian kapiler</td><td>Normal</td><td>Memanjang</td><td>Memanjang, minimal</td></tr><tr><td>Ekstremitas</td><td>Hangat</td><td>Dingin</td><td>Dingin</td></tr><tr><td>Output urin</td><td>Normal sampai menurun</td><td>Menurun</td><td>Minimal</td></tr></table> 5. Demam tifoid dengan keadaan umum yang berat (<i>toxic typhoid</i>). 6. Tifoid dengan komplikasi, antara lain : - Perdarahan usus yang bisa merusak dinding usus - Perforasi atau lubang pada usus - Radang pada jantung atau miokarditis - Infeksi dan peradangan pada berbagai organ tubuh, termasuk hepatitis, gangguan ginjal, dan infeksi kelenjar getah bening 7. Tifoid dengan komorbid yang berat. 8. Telah mendapat terapi dari FKTP namun belum tampak perbaikan	Gejala	Derajat Dehidrasi			Minimal (<3% dari BB)	Ringan sampai sedang (3-9% dari BB)	Berat (>9% dari BB)	Status mental	Baik, sadar penuh	Normal, lemas, atau gelisah, iritabel	Apatis, letargi, tidak sadar	Rasa haus	Minum normal, mungkin menolak minum	Sangat haus, sangat ingin minum	Tidak dapat minum	Denyut jantung	Normal	Normal sampai meningkat	Takikardi, pada kasus berat brakikardi	Kualitas denyut nadi	Normal	Normal sampai menurun	Lemah atau tidak teraba	Pernapasan	Normal	Normal cepat	Dalam	Mata	Normal	Sedikit cekung	Sangat cekung	Air mata	Ada	Menurun	Tidak ada	Mulut dan lidah	Basah	Kering	Pecah-pecah	Turgor kulit	Baik	< 2 detik	> 2 detik	Isian kapiler	Normal	Memanjang	Memanjang, minimal	Ekstremitas	Hangat	Dingin	Dingin	Output urin	Normal sampai menurun	Menurun	Minimal
Gejala	Derajat Dehidrasi																																																							
	Minimal (<3% dari BB)	Ringan sampai sedang (3-9% dari BB)	Berat (>9% dari BB)																																																					
Status mental	Baik, sadar penuh	Normal, lemas, atau gelisah, iritabel	Apatis, letargi, tidak sadar																																																					
Rasa haus	Minum normal, mungkin menolak minum	Sangat haus, sangat ingin minum	Tidak dapat minum																																																					
Denyut jantung	Normal	Normal sampai meningkat	Takikardi, pada kasus berat brakikardi																																																					
Kualitas denyut nadi	Normal	Normal sampai menurun	Lemah atau tidak teraba																																																					
Pernapasan	Normal	Normal cepat	Dalam																																																					
Mata	Normal	Sedikit cekung	Sangat cekung																																																					
Air mata	Ada	Menurun	Tidak ada																																																					
Mulut dan lidah	Basah	Kering	Pecah-pecah																																																					
Turgor kulit	Baik	< 2 detik	> 2 detik																																																					
Isian kapiler	Normal	Memanjang	Memanjang, minimal																																																					
Ekstremitas	Hangat	Dingin	Dingin																																																					
Output urin	Normal sampai menurun	Menurun	Minimal																																																					
Diagnosis Kerja	Typhoid fever																																																							
Diagnosis Banding	1. Demam dengue 2. Malaria 3. Enteritis bacterial																																																							
Tata Laksana	A. Terapi Medikomentosa a. Terapi simptomatik untuk menurunkan demam																																																							

	(antipiretik) Paracetamolmg/hari b. Terapi mengurangi keluhan gastrointestinal. Ondancentronmg/hari c. Terapi antibiotik Seftriakson Dewasa: 2-4gr/hari selama 3-5 hari Anak: 80 mg/kgBB/hari, IM atau IV, dosis tunggal selama 5 hari B. Terapi Non Medikomentosa meliputi: a. Terapi suportif dapat dilakukan dengan: 1. Istirahat tirah baring dan mengatur tahapan mobilisasi Menjaga kecukupan asupan cairan, yang dapat diberikan secara oral maupun parenteral 2. Diet bergizi seimbang, konsistensi lunak, cukup kalori dan protein, rendah serat. 3. Konsumsi obat-obatan secara rutin dan tuntas 4. Kontrol dan monitor tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu, kesadaran) 7 hari setelah rawat inap, kemudian dicatat dengan baik di rekam medik pasien
Edukasi	1. Edukasi mengenai kebersihan air, makanan, dan sanitasi 2. Vaksinasi
Prognosis	Jika tidak diobati, angka kematian pada demam tifoid 10-20%, sedangkan pada kasus yang diobati angka mortalitas tifoid sekitar 2%. Kebanyakan kasus kematian berhubungan dengan malnutrisi, balita, dan lansia. Pasien usia lanjut atau pasien debil prognosisnya lebih buruk. Bila terjadi komplikasi, maka prognosis semakin buruk. Relaps terjadi pada 25% kasus.
Penelaah Kritis	
Indikator	Tercapainya Kendali Mutu & Biaya
Kepustakaan	1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 364/Menkes/SK/V/2006 tentang <i>Pedoman Pengendalian Demam Tifoid</i>. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, t.thn.) 2. Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, eds. <i>Buku ajar ilmu penyakit dalam</i>. 4 ed.

	Vol. III. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI; 2006. (Sudoyo, et al., 2006) 3. Feigin RD, Demmler GJ, Cherry JD, Kaplan SL. Textbook of pediatric infectious diseases. 5th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2004. (Feigin, et al., 2004) 4. Long SS, Pickering LK, Prober CG. Principles and practice of pediatric infectious diseases. 2nd ed. Philadelphia: Churchill & Livingstone; 2003. (Long, et al., 2003) 5. Gershon AA, Hotez PJ, Katz SL. Krugman's infectious disease of children. 11th ed. Philadelphia: Mosby; 2004. (Gershon, et al., 2004) Pomerans AJ, Busey SL, Sabnis S. Pediatric decision making strategies. WB Saunders: Philadelphia; 2002. (Pomerans, et al., 2002) 6. CDC. Typhoid fever. 2005. www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/typhoidfever.g.htm (Center for Disease and Control, 2005) 7. Kalra SP, Naithani N, Mehta SR, Swamy AJ. <i>Current trends in the management of typhoid fever</i>. MJAFI. 2003;59:130-5. (Kalra, et al., 2003) 8. Tam FCH, King TKW, Wong KT, Leung DTM, Chan RCY, Lim PL. <i>The TUBEX test detects not only typhoid-specific antibodies but also soluble antigens and whole bacteria</i>. Journal of Medical Microbiology. 2008;57:316-23. (Tam, et al., 2008) 9. Beig FK, Ahmadz F, Ekram M, Shukla I. <i>Typhidot M and Diazo test vis-à-vis blood culture and Widal test in the early diagnosis of typhoid fever in children in a resource poor setting</i>. Braz J Infect Dis. 2010;14:589-93. (Beig, et al., 2010) 10. Summaries of infectious diseases. Dalam: Red Book Online 2009. Section 3. http://aapredbook.aappublications.org/cgi/content/full/2009/1/3.117 (Anon., 2009) 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No: HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang <i>Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</i>
--	---

Lampiran : 2 (Dua)
 Nomor : 108/DPM/I-PB/DIR/II/2026
 Tanggal : 3 Februari 2026

FORMAT PPK CP DAN RINCIAN BIAYA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Poin	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Hari Rawat					Biaya Pelayanan			Keterangan
					1	2	3	4	5	Kelas 3	Kelas 2	Kelas 1	
	b	Keperawatan											
	c	Gizi											
	d	Farmasi											
14		Kriteria Pulang											
15		Tindak Lanjut											
16		Rencana Pulang											
17		Edukasi Pelayanan Lanjutan											

Hormat kami,
Direktur PT Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE